

BIOGRAFIA DO INSTRUTOR

Quem conduz este módulo

INSTRUTOR

**1º TEN QOCBM
GERALDO**

Oficial Bombeiro Militar
Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco —
CBMPE

FORMAÇÃO

Engenharia Química

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

PÓS-GRADUAÇÃO

Atendimento Pré-Hospitalar (APH)

Base técnica para o manejo de vítimas no ambiente pré-hospitalar

ESPECIALIDADE

APH e Resgate Operacional

Atuação prática em ocorrências de salvamento e emergência

OBJETIVOS DO MÓDULO

O que você deve saber fazer ao final desta aula

- **Reconhecer** os principais animais peçonhentos do Brasil e do Sertão pernambucano.
- **Identificar** sinais de gravidade em picadas de escorpião, serpente, aranha e abelha.
- **Aplicar** as regras de ouro do primeiro atendimento feito pelo público geral.
- **Combater** mitos e práticas caseiras que causam amputações e mortes.
- **Acionar** corretamente o socorro: 193, 192 e CIATOX (0800 722 6001).

REGRA DE OURO

Lavar, acalmar, manter em repouso e levar RÁPIDO ao hospital. O soro antiveneno só existe no hospital — nenhuma receita caseira substitui o tratamento.

PÚBLICO-ALVO

Público geral e pessoas sem treinamento: condutas simples, seguras e que não atrasam o socorro.

OS ANIMAIS PEÇONHENTOS DO MÓDULO

Quatro grupos, condutas parecidas, riscos diferentes

ARACNÍDEOS

ESCORPIÕES

- Gênero Tityus
- Principal causa de acidentes no país
- Grave em crianças

RÉPTEIS

SERPENTES

- Jararaca, cascavel, surucucu e coral
- Soro específico para cada gênero

ARACNÍDEOS

ARANHAS

- Aranha-marrom (Loxosceles)
- Armadeira (Phoneutria)

INSETOS

ABELHAS E VESPAS

- Múltiplas picadas = envenenamento
- Alérgicos: risco de anafilaxia

Atenção: os acidentes por escorpião são hoje os mais notificados entre os acidentes por animais peçonhentos no Brasil — e a casa é o principal local de ocorrência.

PEÇONHENTO × VENENOSO

Uma diferença simples que orienta a conduta

CONCEITO 1

PEÇONHENTO

- Produz veneno E possui estrutura para injetá-lo: presas, ferrão ou quelíceras.
- Exemplos: serpentes peçonhentas, escorpiões, aranhas, abelhas e vespas.

CONCEITO 2

VENENOSO

- Produz veneno, mas NÃO tem como injetá-lo.
- Intoxica por contato ou ingestão. Exemplos: sapo-cururu, baiacu.

FOCO DESTE MÓDULO: ANIMAIS PEÇONHENTOS

O veneno é inoculado ativamente na vítima — por isso o tempo até o soro no hospital é decisivo.

ESCORPIONISMO: ESPÉCIES

Gênero Tityus — os escorpiões de importância médica no Brasil

Tityus serrulatus

ESCORPIÃO-AMARELO

- Tronco escuro; patas e cauda amarelas
- Serrilha no dorso da cauda
- Reproduz sem macho — se espalha rápido nas cidades

Tityus bahiensis

ESCORPIÃO-MARROM

- Tronco marrom-escuro
- Patas com manchas escuras
- Frequente no Sul e Sudeste

Tityus stigmurus

AMARELO DO NORDESTE

- Faixa escura ao longo do dorso
- Espécie mais comum em Pernambuco
- Já causou óbitos infantis no estado

Onde se escondem: entulho, tijolos, madeira empilhada, ralos, esgoto, frestas de parede — e dentro de casa, em calçados, roupas, toalhas e camas.

ESCORPIÃO: SINTOMAS E GRAVIDADE

Sintomas locais e sistêmicos — reconheça a evolução

LEVE

SÓ SINTOMAS LOCAIS

- Dor intensa no local
- Formigamento, vermelhidão e suor local

MODERADO

SINAIS SISTÊMICOS ISOLADOS

- Dor intensa + náuseas
- Vômitos ocasionais, suor, agitação
- Coração e respiração acelerados

GRAVE

RISCO DE MORTE

- Vômitos repetidos e profusos
- Suor generalizado, sonolência ou agitação
- Arritmia, choque, edema pulmonar

SINAL DE ALERTA

Vômitos repetidos após picada de escorpião indicam envenenamento grave: socorro IMEDIATO.

ESCORPIÃO: GRUPOS DE RISCO

Gravidade crítica em crianças menores de 7 anos e idosos

IDADE DE MAIOR RISCO

< 7 ANOS

Menor peso corporal para a mesma quantidade de veneno. A evolução pode ser rápida — nas primeiras horas.

- **Choque cardiogênico:** o veneno sobrecarrega o coração, que deixa de bombear sangue de forma eficaz.
- **Edema agudo de pulmão:** líquido nos pulmões, falta de ar grave — principal causa de óbito.
- **Idosos e cardiopatas:** também têm menor reserva e maior risco de complicações.

CRIANÇA PICADA POR ESCORPIÃO

Levar SEMPRE e IMEDIATAMENTE ao hospital, mesmo que pareça bem nos primeiros minutos.

ESCORPIÃO: PRIMEIRO ATENDIMENTO

Condutas para o público geral, sem treinamento

1

Lavar o local com água e sabão.

2

Compressa morna no local para aliviar a dor.

3

Acalmar a vítima e mantê-la em repouso.

4

Levar ao serviço de saúde — crianças e idosos: imediatamente.

5

Fotografar o animal à distância, só se for seguro.

NÃO FAZER

Espremer, cortar, furar ou sugar o local.
Não aplicar álcool, querosene, alho ou "remédios" caseiros.

ACIONE

193 Bombeiros • 192 SAMU • CIATOX
0800 722 6001 (24 h)

PREVENÇÃO DO ESCORPIONISMO

A melhor conduta é evitar o acidente

DENTRO DE CASA

- Sacudir calçados, roupas e toalhas antes de usar
- Afastar camas e berços da parede
- Telar ralos e vedar frestas e rodapés
- Não andar descalço à noite

QUINTAL E TRABALHO

- Manter o quintal limpo, sem entulho e lixo
- Usar luvas e botas ao mexer em madeira e tijolos
- Examinar frestas antes de pôr a mão
- Guardar alimentos e lixo fechados

CONTROLE AS BARATAS

Baratas são o principal alimento do escorpião — onde há barata, há escorpião.

OFIDISMO: OS 4 GÊNEROS

As serpentes peçonhentas de importância médica no Brasil

Gênero	Nome popular	Ação do veneno	Sinais principais
Bothrops	Jararaca, jararacuçu, urutu	Local e hemorrágica	Dor imediata, inchaço, manchas roxas, sangramentos
Crotalus	Cascavel	Neurotóxica e muscular	Pouca dor; visão turva, pálpebras caídas, urina escura
Lachesis	Surucucu, pico-de-jaca	Local + vagal	Como a jararaca + diarreia, pressão baixa, choque
Micrurus	Coral-verdadeira	Neurotóxica	Pálpebras caídas, dificuldade de engolir, paralisia respiratória

≈ **85%** dos acidentes ofídicos com serpente identificada: jararacas (Bothrops).

JARARACA E SURUCUCU

Venenos de ação local intensa, com dor e inchaço

BOTHROPS

JARARACA

- Dor imediata e inchaço que avança pelo membro
- Manchas roxas, bolhas, sangramento na gengiva ou no local
- Complicações: necrose, infecção e falência dos rins

LACHESIS

SURUCUCU

- Maior serpente peçonhenta das Américas (matas úmidas)
- Quadro local semelhante ao da jararaca
- Síndrome vagal: cólicas, diarreia, pressão baixa, pulso lento, choque

EM COMUM

Veneno de ação local intensa: retire anéis e calçados cedo — o inchaço pode ser rápido.

CASCADE E CORAL-VERDADEIRA

Venenos neurotóxicos: pouca dor local, alto risco

CROTALUS

CASCADE

- Chocalho na cauda; comum em áreas abertas e secas, como o Sertão
- Pouca dor e pouco inchaço no local
- Visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dores musculares
- Urina escura: risco de falência dos rins

MICRURUS

CORAL-VERDADEIRA

- Anéis coloridos (vermelho, preto e branco ou amarelo)
- Quase nenhuma reação no local
- Pálpebras caídas, dificuldade para engolir, fraqueza
- Pode evoluir para paralisia respiratória aguda

PERIGO ESCONDIDO

Ausência de dor NÃO significa ausência de veneno — o quadro neurotóxico pode piorar em poucas horas.

IDENTIFICAÇÃO: SINAIS E ARMADILHAS

Como reconhecer — e quando não arriscar

ARMADILHAS — NÃO CONFIE

- "Cabeça triangular" não é regra segura para saber se é peçonhenta
- Falsas-coraís são quase idênticas às verdadeiras
- Serpente morta ou decapitada ainda pode picar por reflexo
- Filhotes também injetam veneno

SINAIS QUE AJUDAM

- Fosseta loreal (orifício entre olho e narina): jararaca, cascavel e surucucu
- Chocalho ou guizo na ponta da cauda: cascavel
- Escamas eriçadas na ponta da cauda: surucucu
- Anéis coloridos: trate TODA coral como verdadeira

IDENTIFICAR AJUDA, MAS NÃO É OBRIGATÓRIO

A equipe de saúde define o soro pelos sinais clínicos. Nunca atrase o transporte tentando capturar ou matar o animal.

O QUE FAZER: PICADA DE SERPENTE

Sete passos para o público geral

1

Afastar a vítima do animal e acalmá-la.

2

Lavar o local com água e sabão.

3

Repouso absoluto: deitada, sem andar, membro elevado e estendido.

4

Retirar cedo anéis, pulseiras, relógio e calçados.

5

Hidratar: oferecer água se estiver consciente, sem forçar.

6

Fotografar o animal à distância, sem tocar.

7

Ligar 193 / 192 e levar **IMEDIATAMENTE** ao hospital com soro.

TEMPO É TECIDO

Soro nas primeiras horas reduz sequelas e mortes.

O QUE NUNCA FAZER

Combate rigoroso às práticas que mutilam e matam

✖ PROIBIDO

TORNIQUETE OU GARROTE

Prende o veneno no membro: necrose, gangrena e amputação.

✖ PROIBIDO

CORTAR OU FURAR O LOCAL

Não retira veneno; provoca sangramento e infecção.

✖ PROIBIDO

CHUPAR O VENENO

Não funciona, contamina a ferida e expõe quem socorre.

✖ PROIBIDO

BORRA DE CAFÉ, QUEROSENE, FOLHAS

Causam infecção e tétano — e atrasam o socorro.
Nada de álcool.

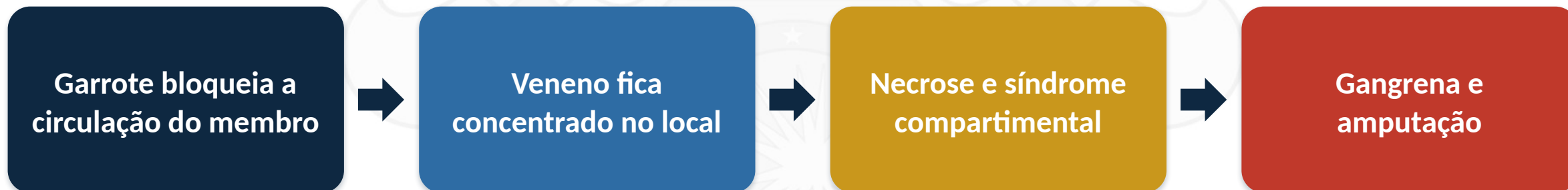
MITOS × VERDADES

O que o povo repete — e o que a ciência mostra

MITO	VERDADE
"O garrote impede o veneno de subir."	Concentra o veneno e mata o tecido: causa gangrena e amputação.
"Cortar e chupar tira o veneno."	Não remove veneno; aumenta sangramento e infecção.
"Cachaça, querosene ou fumo curam."	Pioram o quadro e atrasam a ida ao hospital.
"Borra de café ou alho no local ajudam."	Contaminam a ferida — risco de infecção e tétano.
"Picada sem dor não é grave."	Cascavel e coral quase não doem e podem matar.
"Filhote de cobra é inofensivo."	Filhotes injetam veneno e causam acidentes graves.
"Cobra morta não pica."	O reflexo de bote persiste por um tempo após a morte.

POR QUE O TORNIQUETE É PROIBIDO

Uma sequência que termina em amputação



POR QUE PIORA

Venenos de jararaca e surucucu destroem o tecido no local. Prender a circulação multiplica o dano e não impede a ação do veneno no organismo.

CONDUTA CORRETA

Repouso, membro elevado e estendido, retirar adornos e transporte rápido ao hospital para receber o soro.

SORO ANTIVENENO

O único tratamento específico — e ele está no hospital

Acidente	Soro específico
Jararaca (botrópico)	Antibotrópico (pentavalente)
Surucucu (laquétrico)	Antibotrópico-laquétrico
Cascavel (crotálico)	Anticrotálico
Coral (elapídico)	Antielapídico
Escorpião	Antiescorpiônico ou antiaracnídico
Armadeira	Antiaracnídico
Aranha-marrom	Antiloxoscélico ou antiaracnídico

ONDE SE APLICA O SORO

HOSPITAL

Aplicado apenas por equipe de saúde, com monitoramento de reações. Nem todo caso precisa de soro: a decisão é médica.

ARANHAS: MARROM E ARMADEIRA

Reconhecimento dos sintomas e conduta inicial

LOXOSCELES

ARANHA-MARROM

- Pequena, não agressiva; esconde-se em roupas, toalhas e atrás de móveis
- Picada quase indolor; após 12–24 h: dor, bolha e mancha "marmórea"
- Pode evoluir para ferida necrótica e urina escura

PHONEUTRIA

ARMADEIRA

- Agressiva: ergue as patas dianteiras para atacar
- Vive em bananeiras, entulho, calçados
- Dor imediata e intensa; suor e coração acelerado
- Crianças: vômitos indicam gravidade

CONDUTA

Lavar com água e sabão, compressa morna (armadeira) e levar ao serviço de saúde. Aranha-marrom: procurar atendimento mesmo com pouca dor.

ABELHAS E VESPAS

Do inchaço local ao choque anafilático

NÍVEL 1

REAÇÃO LOCAL

- Dor, vermelhidão e inchaço no local
- Compressa fria e observação

NÍVEL 2

MÚLTIPLAS PICADAS

- Dezenas ou centenas de ferroadas
- Envenenamento: lesão muscular e dos rins
- Levar ao hospital sempre

NÍVEL 3

ALERGIA / ANAFILAXIA

- UMA picada pode matar um alérgico
- Evolução em minutos
- Ligar 193 / 192 imediatamente

RETIRADA DOS FERRÕES

Raspar de lado com um cartão ou lâmina sem fio, sem demora. Não pinçar com os dedos: espreme a bolsa de veneno.

ANAFILAXIA: RECONHECER E AGIR

Reação alérgica grave — minutos contam

PELE

Placas vermelhas pelo corpo, coceira, inchaço de lábios, olhos e língua

RESPIRAÇÃO

Chiado, falta de ar, rouquidão, sensação de garganta fechando

1

Ligar 193 / 192 imediatamente.

2

Adrenalina autoinjjetável: se a pessoa tiver uma prescrita, ajude-a a usar na coxa.

3

Posicionar: deitada com pernas elevadas; com falta de ar, sentada.

4

Vigiar a respiração: se parar, iniciar RCP.

CIRCULAÇÃO

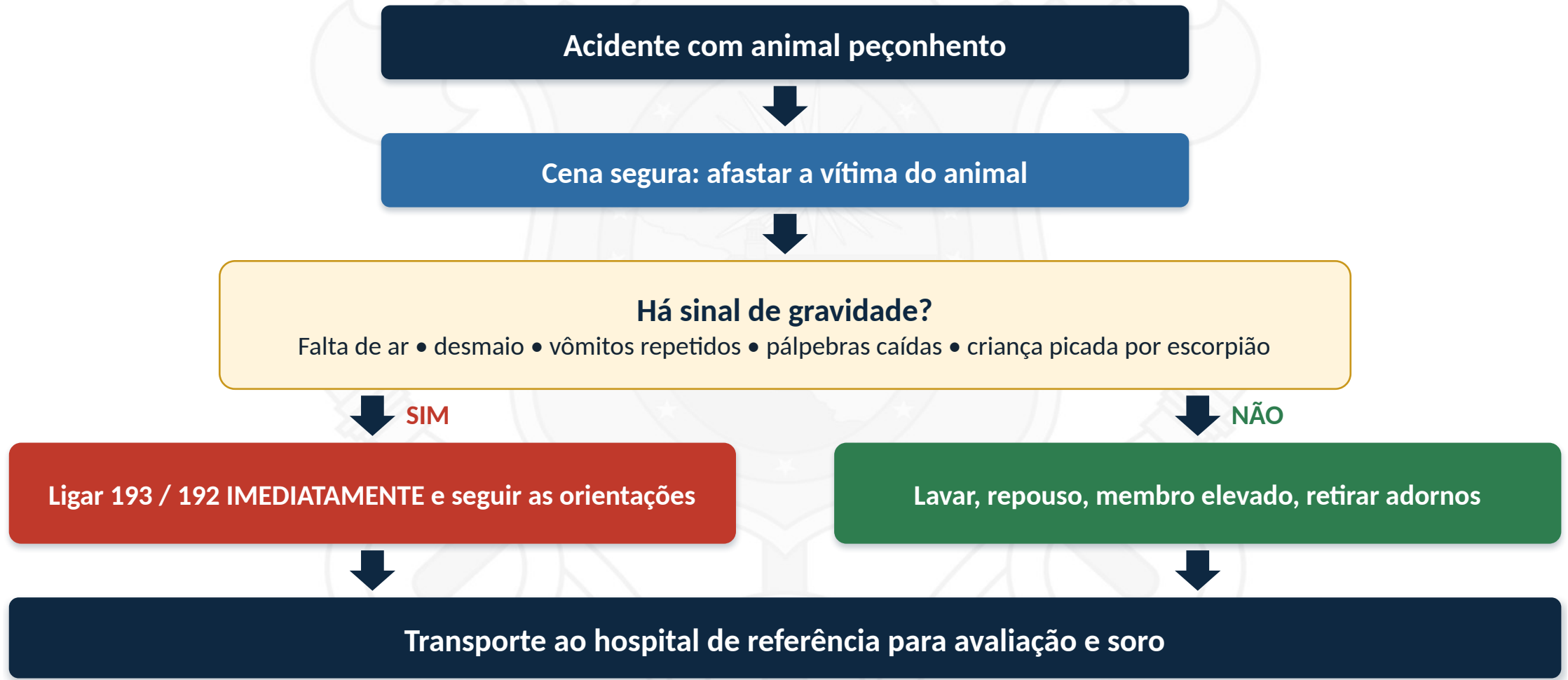
Tontura, desmaio, pele pálida e fria, pulso fraco

DIGESTIVO

Vômitos, cólica, diarreia

FLUXO DE DECISÃO

Da picada ao hospital, sem perder tempo



ACIONAMENTO DO SOCORRO

Números que todo cidadão deve saber

BOMBEIROS

193

Salvamento, resgate e primeiro socorro

SAMU

192

Atendimento médico de urgência

CIATOX / DISQUE-INTOXICAÇÃO

0800 722 6001

Orientação toxicológica 24 h, gratuita

AO LIGAR, INFORME

- Endereço exato e ponto de referência
- Tipo de animal (ou foto) e horário da picada
- Idade da vítima e o que ela está sentindo agora

CASO 1: CRIANÇA E ESCORPIÃO

Menor de 7 anos: prioridade máxima

CASO SIMULADO 1

Escorpião no tênis

Criança de 5 anos é picada por escorpião-amarelo no pé ao calçar o tênis no quarto. Choro desesperado e dor intensa.

Quais passos imediatos a família deve adotar?

1

Retirar o tênis e afastar a criança do local com calma.

2

Lavar com água e sabão e aplicar compressa morna.

3

Ligar 193 / 192 e levar IMEDIATAMENTE ao hospital.

4

Observar no trajeto: vômitos, suor, sonolência, falta de ar.

5

Não aplicar nada no local; foto do escorpião só se for seguro.

CASO 2: AGRICULTOR E JARARACA

Como corrigir um socorro errado no local

CASO SIMULADO 2 Agricultor é picado por jararaca na perna. Um colega quer amarrar uma corda na coxa e fazer cortes para "drenar o sangue". Como intervir?

INTERVIR: IMPEDIR COM FIRMEZA

- Nada de corda ou torniquete: risco de gangrena e amputação
- Nada de cortes: o veneno da jararaca altera a coagulação e o sangramento piora
- Nada de sugar ou aplicar substâncias no local

CONDUTA CORRETA

- Acalmar e deitar o agricultor — ele não deve caminhar
- Lavar com água e sabão; perna elevada e estendida
- Retirar bota e adornos; água se consciente
- Ligar 193 / 192 e transportar ao hospital com soro

QUIZ • QUESTÃO 1 DE 5

Escolha a alternativa correta

QUESTÃO 1 Criança de 5 anos picada por escorpião em casa. Qual a conduta correta?

A

Espremer o local para retirar o veneno

B

Lavar com água e sabão, compressa morna e levar imediatamente ao hospital

C

Aguardar 6 horas para ver se surgem sintomas

D

Aplicar álcool e oferecer chá calmante

QUIZ • QUESTÃO 2 DE 5

Escolha a alternativa correta

QUESTÃO 2 Por que o torniquete é proibido em picada de serpente?

A

Porque só funciona em picadas nas mãos

B

Porque atrasa a chegada do soro ao local

C

Porque concentra o veneno no membro e pode levar a necrose, gangrena e amputação

D

Porque só é permitido em picada de cascavel

QUIZ • QUESTÃO 3 DE 5

Escolha a alternativa correta

QUESTÃO 3 Serpente com chocalho na cauda. A vítima tem pálpebras caídas, visão turva, urina escura e pouca dor local. Qual o gênero?

- | | | | |
|----------|---------------------|----------|-----------------------------|
| A | Bothrops (jararaca) | B | Crotalus (cascavel) |
| C | Lachesis (surucucu) | D | Micrurus (coral-verdadeira) |

QUIZ • QUESTÃO 4 DE 5

Escolha a alternativa correta

QUESTÃO 4 Qual serpente pode causar paralisia respiratória aguda, mesmo com pouca reação no local?

A

Coral-verdadeira (Micrurus)

B

Jararaca (Bothrops)

C

Surucucu (Lachesis)

D

Jiboia (não peçonhenta)

QUIZ • QUESTÃO 5 DE 5

Escolha a alternativa correta

QUESTÃO 5 Após várias picadas de abelha, a vítima tem lábios inchados, chiado no peito e tontura. O que fazer?

A

Dar remédio caseiro e esperar melhorar

B

Pinçar todos os ferrões antes de qualquer outra ação

C

Ligar 193 / 192, posicionar a vítima e ajudar a usar adrenalina autoinjetável se prescrita

D

Aplicar gelo e liberar a vítima para casa

GABARITO COMENTADO (1 A 3)

Fundamentado nas diretrizes oficiais

Q1

B

Água e sabão e compressa morna são as condutas indicadas; criança menor de 7 anos tem alto risco de evolução grave e deve ir imediatamente ao hospital.

Q2

C

O garrote prende o veneno no membro e interrompe a circulação: necrose, gangrena e amputação. O Ministério da Saúde contraindica seu uso.

Q3

B

Chocalho, pouca dor local, quadro neurológico (face miastênica, visão turva) e urina escura são típicos do acidente crotálico.

GABARITO COMENTADO (4 E 5)

Fundamentado nas diretrizes oficiais

Q4

A

O veneno da coral-verdadeira é neurotóxico e pode paralisar os músculos da respiração com mínima reação local.

Q5

C

Os sinais indicam anafilaxia: emergência de minutos. Acionar o socorro, posicionar e usar adrenalina autoinjetável se prescrita.

PARA FIXAR

Em todos os casos: não aplicar nada no local, não fazer garrote e levar rapidamente ao hospital. Na dúvida, ligue 193, 192 ou 0800 722 6001.

REGRAS DE OURO

O resumo que salva vidas

1

LAVE

água e sabão

2

ACALME

repouso total

3

ELEVE

o membro, estendido

4

RETIRE

anéis e calçados

5

LEVE

ao hospital: 193 / 192

✗ NUNCA

Torniquete • cortar • chupar • borra de café, querosene, folhas ou álcool

O soro antiveneno está no hospital — cada minuto conta.

ACIDENTE COM ANIMAL PEÇONHENTO — LIGUE PRIMEIRO PARA O CIATOx 0800 722 6001 • orientação médica 24 h, ligação gratuita

ONDE BUSCAR O SORO EM PERNAMBUCO

Região Metropolitana e Zona da Mata — a rede de referência

ACIDENTE COM ANIMAL PEÇONHENTO — LIGUE PRIMEIRO PARA O CIATOx 0800 722 6001 • orientação médica 24 h, ligação gratuita



REGIÃO METROPOLITANA E ZONA DA MATA

- Hospital da Restauração (HR) — Recife
- Hospital Jaboatão/Prazeres — Jaboatão
- Hospital João Murilo — Vitória de Santo Antão
- Hospital Belarmino Correia — Goiana

Soros da rede: antiescorpiônico • antiofídico (cobras) • antiaracnídico (aranhas)

Em caso de acidente, procure atendimento médico o mais rápido possível.

